

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

EUROPASI · ÍNDICE EUROPEO DE GRAVEDAD DE LA ADICCIÓN

European Addiction Severity Index – Entrevista clínica estandarizada de afectación multidimensional en adicciones

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	European Addiction Severity Index (EuropASI)
Autores Originales	Anna Kokkevi y C. Hartgers (1995); adaptación del ASI de A. Thomas McLellan et al. (1980)
Validación Española	Julio Bobes et al. (1996, 2004) y Grupo de Trabajo EuropASI España
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica semiestructurada multidimensional estandarizada
Población Diana	Pacientes adultos diagnosticados de adicciones a sustancias (alcohol, opioides, cocaína, hipnóticos)
Tiempo de Aplicación	45 a 60 minutos en la evaluación basal (20-30 min en seguimientos evolutivos)
Formato de Respuesta	Datos cuantitativos objetivos (días en el último mes y años históricos) y escalas de severidad (0-9)
Finalidad Clínica	Perfilado biopsicosocial integral de la adicción, planificación personalizada del tratamiento multimodal y evaluación de eficacia en la red asistencial pública y privada

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El tratamiento moderno de las conductas adictivas se asienta sobre la evidencia incuestionable de que la adicción no es meramente un problema biológico de consumo químico, sino una patología biopsicosocial compleja que deteriora múltiples esferas funcionales del individuo. Desarrollado originariamente en el Addiction Research Center de Filadelfia por McLellan y adaptado a los sistemas sanitarios y marcos jurídicos europeos por Kokkevi y Hartgers, el EuropASI es el instrumento nuclear de consenso clínico e investigador más extendido en el continente.

El modelo teórico asume que los problemas en áreas como la salud física, el desempleo, los procesos judiciales o los conflictos de pareja pueden desencadenar recaídas, aun cuando el paciente manifieste una fuerte motivación abstinente. Evalúa siete dimensiones cardinales independientes a lo largo de dos marcos temporales: la gravedad acumulada en toda la vida (**life-time**) y la afectación aguda en los últimos 30 días previos a la consulta.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Área Funcional	Dimensión	Variables Evaluadas y Contenido Específico
1. Estado Médico	Salud Física	Enfermedades crónicas, infecciones (VIH, VHC), hospitalizaciones y prescripción médica.
2. Empleo y Soporte	Socio-Laboral	Fuentes de ingresos legales/ilegales, días trabajados, desempleo y subsidios.
3. Consumo de Alcohol	Sustancia Legal	Días de intoxicación etílica, gasto económico y consecuencias biológicas directas.
4. Uso de Otras Drogas	Sustancias Ilícitas	Uso de heroína, metadona callejera, cocaína, cannabis; vías de administración (EV).
5. Estado Legal	Ámbito Judicial	Detenciones, causas pendientes, juicios, encarcelamientos y actividades delictivas.
6. Relaciones Familiares	Red Social	Conflictos con pareja, padres, hijos; aislamiento y presencia de red de apoyo sana.
7. Estado Psiquiátrico	Salud Mental	Depresión, ansiedad, psicosis, ideación suicida y tratamientos psicofarmacológicos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · EUROPASI

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Fiabilidad Test-Retest	Coeficiente de correlación intraclase ICC = 0.85 a 0.94 entre administraciones consecutivas a los 3-5 días en todas las áreas funcionales.
Fiabilidad Inter-Jueces	Concordancia kappa y coeficientes intraclase superiores a 0.88 entre entrevistadores entrenados acreditados en la red asistencial española (Bobes et al., 1996).
Validez de Constructo	Demuestra alta validez discriminante al distinguir con agudeza diferentes perfiles toxicológicos (patrón alcohólico vs policonsumo opioides/cocaína con delincuencia).
Sensibilidad Evaluativa	Es el instrumento de referencia internacional para monitorizar la rentabilidad terapéutica y los resultados de programas de mantenimiento con agonistas (PMA).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

El EuropASI genera dos tipos de medidas complementarias:

- Puntuaciones de Severidad del Entrevistador (ISR - Interviewer Severity Rating):** El profesional asigna una puntuación de **0 a 9** en cada una de las 7 áreas, evaluando la necesidad de tratamiento adicional según el juicio clínico:
 - 0-1: Ningún problema / tratamiento no necesario.
 - 2-3: Problema leve / tratamiento probablemente no necesario.
 - 4-5: Problema moderado / tratamiento indicado.
 - 6-7: Problema grave / tratamiento necesario con carácter prioritario.
 - 8-9: Problema extremo / necesidad de intervención de urgencia vital o judicial.
- Puntuaciones Compuestas (CS - Composite Scores):** Algoritmo matemático estandarizado que calcula un valor entre **0.00 y 1.00** para cada área con base en los ítems objetivos de los últimos 30 días, utilizado formalmente para medir resultados de investigación.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación ISR	Gravedad del Área	Necesidad Terapéutica	Acción Clínica Coordinada
0 a 1 puntos	Sin Problema	Inexistente	Mantener monitorización preventiva periódica.
2 a 3 puntos	Leve / Controlado	Baja	Consejo sanitario puntual e intervenciones menores.
4 a 5 puntos	Moderado	Requerida	Intervención ambulatoria especializada focalizada.
6 a 7 puntos	Grave	Prioritaria	Tratamiento intensivo en recurso especializado (CAD / Comunidad).
8 a 9 puntos	Extremo / Crítico	Urgente Vital	Intervención inmediata médica, psiquiátrica o legal.

VALOR METODOLÓGICO DEL PERFIL RADIAL DEL EUROPASI: El EuropASI no produce una puntuación global sumada: su mayor fortaleza reside en el diseño de un perfil polidimensional. Un paciente puede presentar un consumo controlado (Alcohol ISR=2) pero un colapso psiquiátrico extremo (Psiquiatría ISR=8) o una crisis legal terminal (Legal ISR=7), lo que define la prioridad del recurso asistencial.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · EUROPASI

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Administración de la Entrevista Basal: Realizar tras lograr la desintoxicación aguda inicial para evitar el sesgo de la confusión por abstinencia.

Paso 2: Articulación del Plan Integral de Cuidados:

- **Si Área Médica ≥ 6 :** Derivar a medicina interna/infecciosas para tratamiento de hepatitis vírica o endocarditis bacteriana.
- **Si Área Psiquiátrica ≥ 6 :** Valorar presencia de patología dual y coordinar con el psiquiatra de enlace la introducción de psicofármacos adecuados.
- **Si Área Empleo/Familia ≥ 6 :** Incorporación inmediata del trabajador social para tramitación de rentas de inserción o acogida residencial.
- **Si Drogas ≥ 6 :** Considerar inclusión en programa de metadona o buprenorfina-naloxona o derivación a comunidad terapéutica cerrada.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 44 años, consumidor de heroína y cocaína en base por vía fumada y parenteral durante 18 años, derivado a un Centro de Atención a las Drogodependencias tras salir de prisión preventiva.

Evaluación Psicométrica Inicial en EuropASI (Puntuaciones ISR):

- **Médica:** 7 / 9. Coinfección crónica por VHC no tratada y abscesos cutáneos en extremidades.
- **Empleo:** 8 / 9. Desempleo de larga duración, sin prestaciones y sin ingresos legales estables.
- **Drogas:** 8 / 9. Consumo diario de heroína (30 días en el último mes) y cocaína (18 días/mes).
- **Legal:** 6 / 9. Dos causas judiciales abiertas por delitos menores contra la propiedad.
- **Familiar:** 7 / 9. Ruptura total de lazos afectivos familiares; vive en infravivienda ocupada.
- **Psiquiátrica:** 6 / 9. Síntomas depresivos moderados con anhedonia e ideación pasiva de muerte.

Plan de Intervención Multidisciplinar: El perfil evidenció que el mero abordaje de la deshabituación fracasaría sin soporte social y médico. Se pautó mantenimiento con buprenorfina/naloxona (16 mg/día), se inició tratamiento antiviral para la hepatitis C con antivirales de acción directa, se tramitó el ingreso en un recurso de alojamiento tutelado y se coordinó informe penal de tratamiento con la asesoría jurídica. A los 6 meses de seguimiento, las puntuaciones ISR en Drogas, Legal y Médica descendieron a 2, 1 y 2 respectivamente.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Una puntuación de 8 o 9 en el área psiquiátrica exige descartar riesgo inminente de suicidio o episodio psicótico paranoide activo.
- En consumo de opiáceos por vía intravenosa, suministrar sistemáticamente kits de naloxona intranasal y educación sobre prevención de sobredosis.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

- **Sesgo de Deseabilidad / Temor Penal:** Verificar las respuestas de causas legales pendientes con fuentes externas si existe litigio activo.
- **Patología Orgánica Concurrente:** No atribuir todo el deterioro psiquiátrico a la sustancia sin descartar encefalopatía hepática.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Kokkevi, A., & Hartgers, C. (1995). European adaptation of a multidimensional assessment instrument for drug and alcohol dependence. *European Addiction Research*, 1(4), 208–210.
- Bobes, J., González, M. P., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (1996). Índice Europeo de Gravedad de la Adicción (EuropASI): Guía de administración y validación. *Adicciones*, 8(4), 423–440.
- McLellan, A. T., Luborsky, L., Woody, G. E., & O'Brien, C. P. (1980). An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients: The Addiction Severity Index. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 168(1), 26–33.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.